

肾盂成形术

患者须知 · 修复肾脏引流通道梗阻的手术

WARWIKI

肾盂成形术（pyeloplasty）是一种手术，用于修复肾脏（kidney）与输尿管（ureter）连接处的梗阻。该连接部位（肾盂输尿管连接部，UPJ）如果过窄，会导致尿液积聚，引起疼痛、感染或肾脏损伤。手术切除梗阻段并重建宽通畅的连接，是最持久的修复方式，成功率超过90%。

关于这项手术

在输尿管顶端与肾脏集合囊（肾盂）相接处，狭窄可减缓尿液排出。有时附近的血管也会压迫该处，这称为肾盂输尿管连接部梗阻（UPJ obstruction）。手术中，医生将：

- 切除狭窄段
- 将健康输尿管与肾盂缝合，形成宽阔的漏斗形连接
- 留置一根柔软的内置支架管（双J管），在愈合期间保持通畅

通常通过机器人辅助或腹腔镜方式完成，仅需几个小切口；少数情况下采用开放切口。

安全吗？

肾盂成形术是成熟、高效的手术，长期成功率超过90%。与所有手术一样，存在一定风险，包括出血、感染或短暂性尿漏（通常由支架管和引流管处理）。梗阻复发并不常见，通常可再次治疗。

名词解释

肾脏（Kidney）

过滤血液并产生尿液的器官。

输尿管（Ureter）

将尿液从肾脏输送至膀胱的管道。

UPJ

肾盂输尿管连接部——肾脏与输尿管的交汇处，即梗阻所在位置。

肾盂（Renal pelvis）

漏斗形腔隙，尿液在此汇集后进入输尿管。

输尿管支架管（Ureteral stent）

内置软管（"双J管"），在愈合期间保持修复处通畅。

跨越血管（Crossing vessel）

压迫连接部并造成梗阻的血管。

肾积水（Hydronephrosis）

尿液在梗阻后方积聚，导致肾脏肿胀。

机器人/腹腔镜手术

通过几个小切口进行的微创手术。

会疼吗？ 手术在全身麻醉下进行，术中无任何感觉。术后小切口处会有酸痛，微创手术使用的气体有时会引起肩部或腹部不适。内置支架管可能导致排尿时有尿急感或轻微侧腹酸痛。大多数患者住院1-2晚，手术通常需要2-3小时。

如何准备（术前）

- 手术在**全身麻醉**下进行——请遵守所有术前指导（禁食，以及需要暂停的药物，包括抗凝药）。
- **尿液检查**排除感染——如有感染须先治疗。
- 做好**支架管在体内留置约4-6周**的准备，并安排他人接送。

术前请提前告知您的医疗团队，如果您：

- 正在服用**抗凝药**，或目前有尿路感染
- 曾接受过肾脏或腹部手术

手术过程

- 1 麻醉生效后您进入睡眠状态，同时给予抗生素。
- 2 医生在腹部做几个小切口（或一个开放切口），暴露梗阻部位。
- 3 切除狭窄段，并对肾盂进行整形。
- 4 将健康输尿管缝合至肾盂，形成宽阔漏斗，内置支架管支撑；根据需要放置小引流管，然后关闭切口。

之后

- 通常住院**一至两天**后出院。
- **支架管在体内保留约4-6周**，之后在门诊通过快速膀胱镜检查取出。
- 支架管相关症状——尿急、排尿时轻微侧腹酸痛或淡红色尿液——属于**正常现象**。
- 术后数周内**避免重体力劳动和用力**，并保持充分饮水。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或畏寒
- 严重或加重的侧腹或腹部疼痛
- 大量出血或尿中出现血块
- 无法排尿，或持续恶心、呕吐
- 切口处红肿加重、疼痛或有渗出

需要记住的三件事

1. 肾盂成形术切除肾脏引流处的梗阻，重建宽通畅的连接——是最持久的修复方式，通常通过小切口微创完成。
2. 准备工作：遵守禁食和用药指导，先治疗感染，做好支架管留置约4-6周的安排，并安排接送。
3. 支架管取出前可能有尿急或侧腹酸痛，属正常。如出现发热、剧烈疼痛、大量出血或无法排尿，请立即就医。